

УДК:616.22-006-07

Ғ.Б.Әділбаев

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Көмей қатерлі ісіктері жәнә оның алдын алу жолдары

Тұжырым. Мақалада көмей қатерлі ісіктерінің таралуы, оның пайда болуының себебі, қатерлі және қатерсіз ісіктердің салыстырмалы клиникасы, тексеру мен емдеу әдістері және оның алдын алу жолдары көрсетілген.

Түйінді сөздер: көмей қатерлі ісіктері, клиникалық белгілері, тексеру, емдеу әдістері, алдын алу жолдары.

Бас және мойын қатерлі ісіктерінің арасында жиі кездесетін қатерлі ісіктерге көмей обыры жатады және оның шамамен 27% құрайды. Жылына Қазақстанда 400 ге жуық көмей қатерлі ісіктерімен ауырған науқас адамдар есепке алынады. Мысалы 2014 жылы 439 аурулар есепке алынса, оның 398 і еркектер болды, науқастардың 57,2% 111-1У стадиясында тіркелді. Бұл сатыларда ауруларға күрделі емдер қолданылады және көбісінде оталық тәсіл қолданып, көмекей толық алынып тасталады да, ауру өмір бақи мүгедек болып, қоғамда қиын жағдайда өмір сүреді. Сондықтан аурудың алдын алу жолдарын жетілдіру, ауруларға уақытында диагноз қою үлкен өзекті мәселе болып есептеледі.

Көмей қатерлі ісіктері пайда болуы үшін әсер ететін себептердің ішінде бірінші орынды темекі тарту алады. Ғылыми зерттеулердің нәтижесінде, 15-20 жылдан астам артық темекі тартатын адамдардың көмейінде әр-түрлі аурудың түрі табылды және көмей қатерлі ісіктерімен ауырған науқастардың 98% темекі тартатын адамдар болды. Сонғы жылдары адамдардың папиллома вирусының көмей қатерлі ісігінің пайда болуына әсері анықталды.

Алкоголь де көмей рагінің пайда болуына әсер етеді. Темекі шегу және арақ өнімдерін жиі ішу көмейдің шырышты қабаттарында өзгерістер туғызып қатерлі ісіктердің пайда болуына себеп болады. Сыртқы ортада канцерогендік әсері бар заттардың (бензол, мұнай және оның өнімдері, химиялық, металлургиялық, құрылыс өндірістерінің шаң-тозаңы, радиоактивті элементтер) көбейуі де үлкен әсер етеді. Әр-түрлі елдердің статистикалық ақпараттарында көмей рагімен ауыратын науқастардың басым көпшілігін мұнай өнімдерімен (шоферлар, механизаторлар), фенолды қарамайымен, кен шығару орындары мен асбест дайындайтын фабрикаларда көп уақыт жұмыс істейтін адамдармен, жұмыс кезінде мамандығы бойынша көп сөйлейтін ксілердің (педагогтар, заңгерлер, диспетчерлер) құрайтынын көрсетеді.

Көмекей ісігінің пайда болуына рақалды аурулары да әсер етеді. Олардың екі түрі болады: облигатты жәнә факультативті. Облигатты рақалды ауруларына папиллома, пахидермия жәнә дискератоздар кіреді. Бұлардың ішінде жиі кездесетіні папиллома жәнә папилломатоз ауруы. Олар көмейдің қатерсіз ісіктерінің 40 пайызын құрайды, ғылыми деректер бойынша, уақытында емделмесе, 10% тен 20% ке жуық папилломалар қатерлі ісікке айналады. Факультативті рақалды ауруына фиброма, аденома, липома, хондрома, гемангиома, лимфангиома жатады.

Рақалды ауруларынан басқа көмейдің шырышты қабатының қабынуы қатерлі ісіктердің пайда болуының алғашқы мезгілі болуы мүмкін. Әр-түрлі авторлардың жазуы бойынша, созылмалы гиперпластикалық ларингит толық емделмесе 5 пайызға жуық науқастарда қатерлі ісіктерге айналады.

Көмейді дәрігерлер үш қабатқа бөледі, әр бөліктің өзінетән қатерлі ісіктердің ерекше белгілері (симтомдары) бар. Егер қатерлі ісік көмейдің жоғарғы немесе кіреберіс бөлігінде пайда болса (50-60%), алғашқы кезде ауру тамағы жыбырлап, аздан кейін оның ісінгенін, тамағында өтпей бөтен бір зат тұрғандай сезім пайда болады. Кейін оған шаншу (ауру сезімі) қосылады, жұтынған кезінде ауырады, тамақтан шыққан шаншу құлаққа да беріледі. Бұл кездерде науқас дәрігерлерге қаралмаса, ауру асқынып оның дауысы өзгереді, кейін тыныс жолдары тарылады.

Егер ауру алдымен көмекейдің ортаңғы бөлігінде пайда болса (30-40%), алдымен ауру адамның даусы өзгереді (қарлығады). Бұл кезде аурулардың көбі оны темекінің әсері, немесе көп сөйлеуден деп ойлайды. Айта кететін тағы бір жай, дауыс қарлығуы суықтың әсерінсіз кенеттен пайда болады. Егер осы уақыттарда ауру адам дәрігерлерге қаралмаса ауру асқынып оның дауысы мүлдем шықпай қалады, тыныс жолдары тарылып ентіге бастайды, кей кезде жоғарғы тыныс жолдары мүлдем бітеліп қалып науқасқа жедел операция жасауға тура келеді.

Ауру көмейдің төменгі бөлігінде пайда болса (5-7%), оның тағы да алдымен дауысы өзгереді, ісік өскен сайын біртіндеп тыныс жолдары тарылып ентігеді.

Кей кездерде аурудың алғашқы белгісі – мойын бездерінің шошынуы, ісіп үлкен болуы, одан кейін ғана дауыстың өзгеруі жәнә тыныс жолдарының тарылуы (ентігу) басталады.

Сонымен көмейде қатерлі ісіктер пайда болған кезде мынандай белгілермен (симтомдармен) білінеді: тамақтың жыбырлап оның қабынуы, тамақта өтпей бөтен зат тұрған сияқты сезім, жұтынған кезде ауруы, шаншудың құлаққа берілуі, дауыстың өзгеруі-қарлығуы, шықпай қалуы, тыныс жолдарының тарылуы, ауа жетпей ентігуі жәнә мойын бездерінің ісінуі.

Диагноз қою үшін дәрігерлер науқастардың шағымын сұраған соң пальпация, жанама ларингоскопия арқылы көмейді қарайды. Толық диагноз қою үшін фиброларингоскопия, рентгенологиялық, ультрадыбыс арқылы зерттеу әдістерін қолданады. Зерттеудің ең соңында ісіктен биопсия жасап оған морфологиялық зерттеу жүргізеді.

Қазіргі уақытта көмей қатерлі ісіктерін емдеу үшін радиологиялық (сәулемен емдеу), хирургиялық жәнә дәрімен (химиотерапевтік) емдеу әдістері қолданады. Егер аурудың алғашқы сатыларында (1-11 стадия) сәуле мен хирургиялық тәсілдерді қолдану арқылы науқастардың 80-90% толық емдеу жазуға мүмкіндік болса, аурулардың асқынған стадияларында күрделі емдеулер қолдану арқылы (көбісінде оталық тәсіл қолданып,

көмекей толық алынып тасталады) 40-55% науқас адамдар жазылады. Ларингэктомия отауынан кейін науқастың сөйлеу қабілетін қалпына келтіру үшін дауыс протезі, электронді көмей немесе логопедиялық әдістер қолданылады. Бүгінгі күндерде көмей қатерлі ісіктерін

алдын алу жолы – салауатты өмір сүру. Темекі тартпау, арақ ішпеу, жоғарыдағы біз жазған аурулардың белгілері пайда болғандарда ғана дәрігерлерге қаралмай, жыл сайын алдын-ала тексерілу, рақалды ауруларын уақытында емдеу.

Қолданылған әдебиеттер

1. Нургазиев К.Ш., Байпейсов Д.М., Ауезова Э.Т. и др. Показатели онкологической службы РК за 2014 г. (статистические материалы).- Алматы, 2015.

2. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. –М., 2013.- С.170-198.

3. Адильбаев Г.Б., Абисатов К.А., Адильбай Д.Г. Избранные главы опухолей головы и шеи. -Алматы, 2015.- С.137-174.

Аннотация
Г.Б.Адильбаев

Казахский научно-исследовательский институт
онкологии и радиологии

Рак гортани: диагностика и профилактика

В статье представлены заболеваемость злокачественными опухолями гортани в Республике Казахстан, причинные факторы, его клиническое проявление, методы дифференциальной диагностики, лечения, реабилитации и профилактики.

Ключевые слова: рак гортани, клиника, диагностика, лечение и профилактика

Summary
G.Adilbayev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Cancer of the larynx: diagnostics and prevention

The article presents the morbidity of malignant tumors of the larynx in the Republic of Kazakhstan, causal factors, its clinical manifestation, methods of differential diagnostics, treatment, rehabilitation and prevention.

Keywords: cancer of the larynx, clinic, diagnostics, treatment and prevention